

Resumen de la unidad 5: análisis de extensiones cervicovaginales en procesos neoplásicos.

Colores:

Azul: células atípicas.

Verde: lesiones de bajo grado.

Naranja: lesiones de grado medio.

Rosa: lesiones de alto grado.

Rojo: carcinomas y adenocarcinomas.

Terminología.

- **Carcinoma in situ (CIS).** Lesiones epiteliales totalmente compuestas de células que tienen todas las características de malignidad, pero sin crecimiento invasivo.
- **Displasia.** Parte del grosor del epitelio se encuentra reemplazado por células que muestran varios grados de atipia. No queratinizante, metaplásica y queratinizante o pleomórfica.
- **Lesión intraepitelial pavimentosa** (LIP o SIL) de bajo (L-SIL) y alto grado (H-SIL). Lesiones en general.
- **Neoplasia cervical intraepitelial** (CIN). Lesiones intraepiteliales que preceden al carcinoma invasor. Tres grados.

- CIN I = displasia leve = L-SIL (y L-SIL también incluye además infección por VPH).
- CIN II = displasia moderada = H-SIL.
- CIN III = displasia severa y carcinoma in situ = H-SIL.

Anomalías de las células epiteliales escamosas.

Células escamosas atípicas (ASC) que pueden ser de significado indeterminado (ASC-US) o sin poder excluir una lesión de alto grado (ASC-H). Serán de un tipo u otro según sean poco o muy atípicas, diferentes de las normales, respectivamente. Cuando se encuentran, la paciente necesita que se le haga un seguimiento.

Células	Características citológicas
ASC.	• Suelen ser células pavimentosas maduras o de tipo metaplásico. • Los núcleos poseen un aumento de tamaño aproximadamente 2-3 veces el de una célula intermedia escamosa normal. <u>Se mantienen N/C.</u> • Normocromasia o ligera hipercromasia. Distribución homogénea de la cromatina y contornos nucleares lisos y uniformes.

SIL

Suelen aparecer en la zona de transformación. Si hay progresión, existe un periodo de tiempo más o menos largo para que lleguen a transformarse en un carcinoma invasor. La prevención y el tratamiento rápido son importantes. L-SIL se detecta entre 25-30 años y H-SIL entre los 32 y 41 años de media.

L-SIL

Lesión	Características histológicas	Características citológicas
Infección por VPH.	• Parecido a CIN I con presencia en los estratos intermedio y superficial de vacuolizaciones citoplasmáticas con núcleos atípicos (coilocitosis). • Engrosamiento del epitelio por hiperplasia celular (acantosis) • Hiperqueratosis o paraqueratosis en la superficie epitelial. • Proyecciones epiteliales de aspecto verrugoso (condilomas).	• <u>Coilocitosis</u>. Células intermedias o superficiales con un espacio perinuclear definido, claro y con un anillo periférico engrosado. Atipias nucleares: cariomegalia, hipercromasia, cromatina gruesa no uniforme, contornos nucleares irregulares y <u>binucleaciones</u>. • <u>Disqueratinocitos</u>. Células relativamente pequeña. Citoplasma orangiófilo, núcleos hipercromáticos. Agrupadas o aisladas.
CIN I (displasia leve).	• Alteraciones predominantes en las capas parabasales del epitelio. • Preservación de la estratificación y maduración en los dos tercios superiores del epitelio.	• Los cambios afectan a células escamosas de tipo intermedio o superficial maduras, con bordes celulares poligonales bien definidos. • Núcleos aumentados de tamaño, cromatinas granulares finas y distribución uniforme. Contornos lisos y regulares, a veces ligeras irregularidades. • Presencia de <u>binucleaciones</u>.

H-SIL

Lesión	Características histológicas	Características histológicas
CIN II (displasia moderada).	• Los dos tercios del espesor del epitelio contienen células marcadamente anormales de aspecto inmaduro, con pérdida de polaridad, estratificación y orientación celular. Se pueden observar la presencia de figuras mitóticas. • Solo el tercio superior con maduración y estratificación. Células de tipo intermedio y superficial con núcleos aumentados de tamaño y ligeramente hipercromáticos. • Ocasionalmente, signos de queratinización.	• Variabilidad en el tamaño celular, con presencia sobre todo de células anómalas de tipo intermedio o <u>parabasal</u>. • Presencia de núcleos redondos u ovales, pero de contornos irregulares, con cromatina de distribución uniforme y moderadamente hipercromáticos. Anisocariosis y multinucleaciones ocasionales. • La relación N/C está alterada, ocupando el núcleo menos de la mitad del área total de la célula.
CIN III (displasia severa).	• Prácticamente todo el epitelio con gran distorsión en su celularidad, a veces solo presente la estratificación en las capas más superficiales. • A través de todo el epitelio, células parabasales inmaduras con disminución del	• Células anómalas de tipo parabasal con escaso citoplasma, a veces poco definido y basófilo. En lesiones queratinizadas, eosinófilos. • Marcadas alteraciones nucleares. Cariomegalia, anisocariosis, hipercromatismo, cromatina gruesa de distribución irregular e irregularidades en los contornos.

	volumen citoplasmático y aumento del tamaño nuclear. Mitosis en cualquier nivel. • Hiperchromasia, cromatina gruesa y de distribución irregular.	• Células generalmente sueltas, pérdida de cohesividad, o láminas con bordes celulares poco definidos.
CIN III (Carcinoma in situ).	• Todo el epitelio está reemplazado por células primitivas sin evidencia de maduración. • La polaridad nuclear puede ser vertical o estar ausente. A veces las células de las capas superiores tienen una disposición horizontal. • Núcleos intensamente hiperchromáticos y aumentados de tamaño. Mitosis frecuentes y pueden estar en cualquier nivel.	• Numerosas células anormales en los extendidos, generalmente formando agregados sincitiales con tendencia a la superposición. • Células sueltas de tipo parabasal o metaplásico inmaduro, con citoplasmas basófilos y núcleos aumentados de tamaño. Pérdida de la relación N/C. • Núcleos hiperchromáticos, con distribución irregular de la cromatina y contornos redondos u ovales. A veces, núcleos desnudos. • Ausencia de diátesis tumoral.

Carcinoma escamoso

Variantes: verrucoso, condilomatoso, papilar escamoso y linfopitelial.

Diátesis tumoral: fondo sucio con abundantes detritos, material granular proteináceo, sangre mal preservada e infiltrado inflamatorio.

Lesión	Características histológicas	Características citológicas
Carcinoma infiltrante o invasor.	• Carcinoma no queratinizante de célula grande. Tipo más frecuente. Crecimiento endofítico. Áreas próximas a zona endocervical de la UPC. Pequeñas masas tumorales o nidos celulares, de límites redondeados, que invaden el estroma y están separados por gruesas bandas de tejido conectivo. Reacción de células monocitarias. No queratinización. • Carcinoma de célula pequeña. Su presentación es la menos frecuente. Es muy agresivo y prolifera rápidamente, metástasis a distancia. Crecimiento endofítico. Masas o nidos celulares de aspecto sincitial. Células pequeñas y uniformes. Sin queratinización. • Carcinoma escamoso queratinizante. Crecimiento exofítico. Porción endocervical de la UPC. Masas de células con infiltración irregulares. Paraqueratosis y/o hiperqueratosis. Perlas córneas malignas.	• Presencia de células sueltas con gran pleomorfismo y de grandes placas celulares que corresponden a verdaderos fragmentos tumorales. • Gran variabilidad en la forma y el tamaño de los citoplasmas, de coloración orangiófila (cuando es queratinizante) o de tonalidad basófila. • Marcadas alteraciones nucleares. Anisocariosis, gran pleomorfismo, hipercromatismo, cromatina granular gruesa, núcleos en tinta china, multinucleación y multilobulación. • En ocasiones, perlas córneas e imágenes de canibalismo celular. • Diátesis tumoral. • Células correspondientes a lesiones epiteliales, adyacentes al carcinoma.

Anomalías de las células epiteliales glandulares.

Células glandulares atípicas. AGC-NOS y AGC-Favor Neoplasia. Pueden ser endocervicales y endometriales.

Células	Características	Causas
Células endocervicales atípicas.	• Distribución celular en láminas, a veces con presencia del patrón en panal de abeja. • Amplios citoplasmas con bordes celulares más o menos netos. • Aumento de tamaño del núcleo de 3 a 5 veces el de una célula endocervical normal. • Ligera hiperchromasia, con distribución homogénea de la cromatina. • A veces hay nucléolos evidentes.	• Procesos inflamatorios. • Procesos de tipo reparativo. • Anticonceptivos orales. • Hiperplasia endocervical microglandular. • Pólipos endocervicales. • Endometriosis cervical.
Células endometriales atípicas.	• Pequeños grupos celulares. • Núcleos aumentados ligeramente de tamaño, hiperchromáticos, menos cantidad de citoplasma.	• Metaplasia escamosa endometrial.

Adenocarcinoma cervical.

Variantes: de célula clara, villoglandular papilar y seroso papilar.

Lesión	Características histológicas	Características citológicas
Adenocarcinoma cervical in situ (AIS). Cuatro variantes histológicas: • Endocervical. • Intestinal. • Endometroide. • Adenoescamoso.	• Presencia de glándulas normales y neoplásicas, a veces con una transición abrupta del epitelio, con conservación de la arquitectura epitelial. • Lesión limitada al epitelio glandular, con ausencia de respuesta inflamatoria estromal. • Estratificación nuclear, con núcleos aumentados de tamaño, hipercromáticos y con presencia de figuras mitóticas anormales.	• <u>Amontonamiento celular y pseudoestratificación</u>. Tiras, grupos papilares y rosetas de aspecto pseudoglandular. En estos, disposición especial de los núcleos situados en los márgenes (feathering). • Núcleos elongados con anisocariosis y cariomegalia. • Cromatina gruesa de distribución irregular e hipercromasia. • Sin diátesis tumoral.
Adenocarcinoma invasor.	• Su morfología está en relación con el grado de diferenciación. • En las formas bien diferenciadas, las células cancerosas se disponen formando estructuras glandulares ramificadas, densamente	• Puede haber grupos celulares de aspecto moruliforme, papilar, acinar o formando rosetas. El amontonamiento de los núcleos y la superposición sugieren invasión tumoral.

	aglomeradas y con formación de procesos papilares intraluminales. • Las glándulas aparecen distorsionadas por la presencia de núcleos aumentados de tamaño, hipercromáticos y de contornos irregulares, variaciones en tamaño y forma. • Puede hacer vacuolas productoras de moco. • Estroma escaso e invasión por las células tumorales.	• Los núcleos están aumentados de tamaño y presentan anisocariosis, hipercromasia, cromatina granular gruesa y nucléolos prominentes. • Puede haber <u>vacuolizaciones</u> citoplasmáticas. • Diátesis tumoral. • En ocasiones pueden verse formas mixtas de carcinoma escamoso y carcinoma glandular (adenocarcinoma).
--	--	--

Otros tumores malignos de cuello uterino.

Tumores primarios	Metástasis
• Sarcoma. • Melanoma. • Linfoma. • Carcinomas indiferenciados.	• Del propio tracto genital femenino. Los más frecuentes. • De origen extragenital. • El cáncer de cérvix puede causar metástasis.